

Conducto ileal

WARWIKI

Información para el paciente · Una derivación urinaria que drena en una bolsa de ostomía

El conducto ileal es una forma de drenar la orina cuando se extrae la vejiga o esta ya no funciona. El cirujano usa un trozo corto de su propio intestino para llevar la orina desde los riñones hasta una pequeña abertura en el abdomen (un estoma), donde drena en una bolsa ligera que usted lleva. Es la derivación urinaria más sencilla y común.

Acerca de este procedimiento

Se usa un **trozo de intestino delgado de 6 a 8 pulgadas** como **conducto de paso** — no almacena orina. Los uréteres (los tubos de los riñones) se conectan a él, y un extremo se lleva a la piel como **estoma**, casi siempre en el abdomen inferior derecho. Como la orina drena de forma **continua**, usted lleva una bolsa ligera (una **bolsa de ostomía**) sobre el estoma, que vacía durante el día y cambia cada pocos días.

- No hay **nada que controlar ni que cateterizar**.
- El resto del intestino se **vuelve a unir** para que la digestión siga normal.
- Una **enfermera de ostomía** le enseña a cuidar el estoma y la bolsa.

¿Es seguro?

El conducto ileal ha sido la derivación incontinente estándar por más de 70 años — es la más sencilla y la de operación más corta. Como toda cirugía mayor, tiene riesgos (sangrado, infección, una fuga donde se unen el intestino o los uréteres). Con el tiempo, algunas personas tienen problemas del estoma o la piel, infecciones de orina o cambios de sales/vitaminas — todo se vigila en el seguimiento.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Derivación urinaria

Un nuevo camino para que la orina salga del cuerpo cuando la vejiga ya no está o no funciona.

Conducto ileal

Un trozo corto de intestino delgado que lleva la orina a un estoma.

Estoma

La pequeña abertura en el abdomen, hecha de intestino, por donde sale la orina.

Bolsa de ostomía

La bolsa (dispositivo) que se lleva sobre el estoma para recoger la orina.

Uréteres

Los tubos que llevan la orina desde los riñones; se unen al conducto.

Enfermera de ostomía

Enfermera que marca el sitio del estoma y enseña su cuidado y el de la bolsa.

Moco

Líquido resbaloso que produce el intestino; los hilos en la orina son normales.

Piel periestomal

La piel alrededor del estoma, que se mantiene limpia y protegida.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general, así que no siente nada durante ella. Después, espere dolor en el abdomen, y el intestino tarda unos días en “despertar” (empieza con líquidos y va aumentando). El estoma en sí no tiene sensibilidad. La mayoría queda en el hospital unos 5 a 7 días.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes). Puede llevar una **preparación intestinal**.
- Conozca a la **enfermera de ostomía**, que marca el mejor sitio del estoma mientras usted se sienta, se para y se acuesta — clave para un ajuste cómodo y sin fugas.
- **No fume** — retrasa la cicatrización — y organice ayuda en casa para después.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección activa
- Tiene **enfermedad intestinal** (como Crohn o colitis) o cirugía o radiación abdominal previa

Qué sucede durante la cirugía

1. Está dormido con anestesia y se administran antibióticos.
2. Se aparta un trozo corto de intestino y el resto se vuelve a unir.
3. Los uréteres se unen al segmento de intestino.
4. Un extremo se saca por el abdomen como estoma; se colocan catéteres suaves y un drenaje mientras sana.

Después de la cirugía

- Vuelve a casa en **5 a 7 días**. La enfermera de ostomía le enseña a **vaciar la bolsa** y a **cambiar el dispositivo**.
- Los hilos de **moco** en la orina son normales — los produce el intestino. **Tome muchos líquidos** y cuide la piel del estoma.
- **Evite cargar peso ~6 semanas**. Tendrá controles de por vida (función renal, vitamina B12).

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- El estoma se pone **oscuro, morado o se hunde hacia adentro**
- **Poca o ninguna orina** en la bolsa por varias horas
- Dolor abdominal fuerte, vómitos o **no expulsar gases ni heces**
- Sangrado abundante, o enrojecimiento o secreción en la herida

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El conducto ileal usa un trozo corto de intestino para drenar la orina a un estoma del abdomen, dentro de una bolsa — la derivación más sencilla, sin nada que cateterizar.
2. Para prepararse: siga el ayuno y la preparación intestinal, conozca a la enfermera de ostomía para marcar el estoma, no fume y organice ayuda en casa.
3. El moco en la orina es normal, y la enfermera de ostomía le enseñará el cuidado de la bolsa y la piel. Llame si hay fiebre, estoma oscuro, sin orina en la bolsa, o un abdomen que no expulsa gases ni heces.